Estrategia de adopción

Cartagenaeste · Plataforma formativa Área II

Autor: Carlos Galera Román

Fecha: 2026-04-24

Horizonte: 2026-04-25 · sesión pacientes

Horizonte: 2026-05-08 · sesión hospital

Documento interno · No difundir sin autorización del autor

1. Situación actual en una frase

Tienes una plataforma formativa que ya funciona clínicamente en Urgencias HGU Santa Lucía pero con solo **5 usuarios registrados en Auth** (todos de tu círculo personal). Los profesionales del servicio probablemente consultan contenido público sin loguearse, pero **no están contribuyendo al repositorio común** ni usando las funciones con IA de manera sistemática. El objetivo de las próximas dos sesiones es convertir ese uso pasivo en una **red activa de aportaciones**.

2. Dos audiencias, dos mensajes

2.1 Pacientes — sesión 25 abril 2026

Perfil psicográfico

- Edad media 55–75, adherentes al sistema público.
- Desconfianza leve hacia "aplicaciones" (identificado como "cosa de jóvenes").
- Alto interés si detectan **utilidad inmediata para resolver dudas** o **acceso más rápido al médico**.

Mensaje nuclear

> *"Es una herramienta hecha por tu médico para ti. Entras con el móvil, miras la información que te interesa y llegas a la consulta mejor preparado. Ni dar datos personales, ni descargar nada."*

Anclas persuasivas

1. **Familiaridad:** "Igual que revisas el tiempo antes de salir, aquí revisas tu consulta antes de ir al médico."
2. **Autoridad del autor:** "Lo ha hecho un médico de vuestro centro, no una empresa."
3. **Gratuito y privado:** "No pide DNI, ni email obligatorio, ni vende datos."
4. **Sin ansiedad tecnológica:** "Si os perdéis, vuestros hijos os lo enseñan en 2 minutos. La home tiene 3 botones grandes."

Secciones a destacar en voz alta

- `prepara-consulta.html` · preguntas a llevar al médico.
- `consejos-salud.html` · fichas de enfermedades crónicas.
- `recursos-comunitarios.html` · teléfonos útiles, farmacias, dependencia.
- `chatbot-medicacion.html` · interacciones medicamentosas básicas.

Llamada a la acción

Escanear el QR en ese momento. **No pedir registro al paciente**, solo que la guarde en favoritos del navegador. Login opcional mencionado como "si queréis probar la parte de inteligencia artificial para preparar dudas, os registráis cuando queráis".

> **Métrica de éxito sábado 26:**
> • 20–45 usuarios nuevos en GA4 con `utm_source=sesion-pacientes-25abril`
> • Pico de tráfico en franja 18:00–22:00 en `prepara-consulta.html` y `consejos-salud.html`
> • Bonus: 3–5 registros Auth con @gmail.com

2.2 Profesionales sanitarios — sesión 8 mayo 2026

Perfil psicográfico

- Médicos adjuntos, residentes, enfermería de Urgencias HGU Santa Lucía.
- Alta carga asistencial → intolerancia a herramientas que añaden fricción.
- Escépticos de IA por mala experiencia con demos corporativas (ChatGPT genérico, Copilot sin contexto clínico).
- Valoran: rapidez, precisión farmacológica, trazabilidad, datos en UE.

Mensaje nuclear

> *"Esto no te pide que cambies cómo trabajas. Te ahorra clicks. Te da el vademécum, los protocolos y la calculadora en un sitio. Y cuando le enseñas un caso, la IA te devuelve un diagnóstico diferencial razonado que puedes corregir, no un texto genérico."*

Anclas persuasivas

1. **Autoridad de par:** "Lo uso yo en guardia. Ramón también. Preguntadles."
2. **Contexto clínico local:** "El vademécum tiene medicación según SMS, no según nomenclator yankee. Los recursos sociales son los de Cartagena."
3. **Seudonimización estricta:** "No guarda DNI, no guarda NHC. Solo iniciales + número de cama. App Check enforcado en producción."
4. **Valor IA real:** "La IA no está para reemplazar tu juicio. Está para acelerar el diagnóstico diferencial cuando tienes 15 pacientes en espera y la residente de guardia está en el politraumático."
5. **Red comunitaria:** "Cada caso que subes aporta al repositorio. Cada plantilla que haces la pueden usar los demás. Es un cuaderno compartido de guardia, no una app comercial."

Bloque obligatorio de 3 minutos en la charla

1. Proyecta `https://area2cartagena.es/profesionales.html` en pantalla grande.

2. "Sacad el móvil ahora. Escanead el QR."
3. "Dadle a 'Iniciar sesión con Google' — no os pide instalar nada."
4. "Que cada uno confirme al de al lado que ha visto la pantalla de bienvenida."
5. Tú refrescas `admin-dashboard.html` en pantalla y ves llegar los registros en vivo. **Aplauso colectivo cuando lleguéis a 10**.

Secciones a demostrar en vivo (elegir 2, no más)

- **Scan IA** (`scan-upload.html`): sube foto de ECG o analítica → IA la interpreta en menos de 15 s.
- **Triaje IA** (`triaje-ai.html`): introduce síntomas → propone gravedad Manchester + actitud inicial.
- **PROA** (`proa.html`): busca antibiótico por germen → sale la recomendación local SMS.

Llamada a la acción · 3 compromisos por profesional

1. **Suscribirse:** login con Google (obligatorio para la parte IA).
2. **Contribuir:** enviar 1 caso clínico seudonimizado en el primer mes vía `sugerencias.html`.
3. **Compartir:** enseñárselo a 1 compañero/a en la próxima guardia.

> **Métrica de éxito viernes 9 mayo:**
> • 15–30 registros nuevos en Auth con @gmail.com (muchos SMS usan gmail personal para apps)
> • Crecimiento del top gastadores de DeepSeek en el dashboard admin
> • Primeras sugerencias anónimas en la colección `sugerencias`
> • `utm_source=sesion-hospital-8mayo` disparándose en GA4

3. Arquitectura persuasiva: por qué una "red" y no una "app"

La pregunta repetida que te harán será: "*Pero… ¿tengo que meter datos ahí?*"

Respuesta marco

> *"Esto no es una base de datos de pacientes. Es un **repositorio común de conocimiento** donde:*
>
> - *Los **pacientes** encuentran información validada por un médico de su centro.*
> - *Los **médicos** encuentran una segunda opinión IA para casos complejos.*
> - *La **enfermería** tiene las calculadoras y escalas clínicas a un click.*
> - *Y **todos** contribuimos con casos, plantillas, y sugerencias que acaban beneficiando al siguiente profesional o paciente."*

Tres argumentos finales para desbloquear al escéptico

1. **"Ya existe. Ya funciona. No te pido que creas en nada, te pido que la mires 2 minutos."**

2. **"No te cuesta nada. Ni descargar, ni registrarte obligatorio, ni dar DNI. Si no te sirve, cierras la pestaña."**
3. **"Tu participación mejora la herramienta para tus residentes y para tus pacientes. No me beneficia a mí; me beneficia si a todos nos pasa lo mismo."**

4. Anti-patrones a evitar

❌ NO HAGAS ESTO	✅ HAZ ESTO EN SU LUGAR
"Es una app de inteligencia artificial para medicina"	"Es el cuaderno de guardia de Cartagena, con IA cuando la necesitas"
Hablar de GPT-4 / DeepSeek / arquitectura técnica	"Te ahorra 3 clicks" · "el vademécum está local"
Pedir "registraos cuando podáis"	"Sacad el móvil. 2 minutos. Ahora."
Presentar todas las funciones	Demostrar 2 funciones bien, dejando curiosidad
Mencionar "replicable a otras áreas" / "proyecto escalable"	"Está pensado para Cartagena. Si sale bien, otros copiarán"

5. Post-sesión: cómo capitalizar el momentum

Primeras 48 h tras cada sesión

- Revisar `admin-dashboard.html` → sección GA4 filtrada por `utm_source` de la sesión correspondiente.
- Contar registros nuevos en Auth.
- Identificar early adopters por emails del dashboard → WhatsApp personal de agradecimiento individual.

Primera semana

- Enviar al grupo de WhatsApp de Urgencias 1 caso destacado anonimizado generado con la IA.
- Publicar en LinkedIn: "Tras la sesión del 8 mayo, N profesionales del Área II ya usan Cartagenaeste. Gracias a todos."

Primer mes

- Sesión de feedback abierta (30 min) para recoger mejoras. Acudir con 1 mejora ya implementada.
- Primer informe mensual para Dirección Médica (PDF del propio dashboard, sección KPIs para reporting).

6. Ficha rápida del día D (imprimir y llevar al bolsillo)

Pacientes · 25 abril 2026

1. QR: `https://area2cartagena.es/?utm_source=sesion-pacientes-25abril`
2. Abrir `prepara-consulta.html` y `recursos-comunitarios.html` en el proyector.
3. Frase clave: **"Ni registro, ni DNI, ni descargar nada."**
4. CTA: "Guardadla en favoritos. Si queréis, registraos."

Profesionales · 8 mayo 2026

1. QR: `https://area2cartagena.es/profesionales.html?utm_source=sesion-hospital-8mayo`
2. Abrir `scan-upload.html` y `triaje-ai.html` en el proyector.
3. Frase clave: **"Ya funciona. No es una demo. Es vuestro cuaderno."**
4. CTA bloqueo de 3 minutos: móvil → QR → Login Google → grito colectivo al llegar a 10 registros.

7. Dashboard de seguimiento

Tras los eventos, abre `https://area2cartagena.es/admin-dashboard.html` (solo cuenta `carlosgalera2roman@gmail.com`) y revisa:

SECCIÓN	QUÉ MIRAR	UMBRAL DE ÉXITO
🌐 Tráfico web (GA4) · filtro area2	Sesiones con `utm_source=sesion-*`	> 20 en primeras 24 h
👥 Top usuarios por coste	Emails nuevos tras las sesiones	> 10 emails nuevos
🏢 Distribución por dominio	Proporción @gmail.com vs otros	@gmail.com > 60%
🔥 Gasto por proveedor IA	Top 3 gastadores DeepSeek	3 usuarios distintos de ti
🤖 Uso por modelo	Coste mensual DeepSeek	< 5 € con 30 usuarios activos

8. Plantilla para Dirección Médica (si el 8 mayo sale bien)

> ***Estimada Dra. XXXX,***
>
> *Tras la sesión del 8 de mayo de 2026, `Cartagenaeste` — la plataforma formativa desarrollada internamente en el Área II — ha pasado a ser utilizada activamente por N profesionales del servicio de Urgencias HGU Santa Lucía.*
>
> *Datos de las primeras 2 semanas:*
>
> - *N usuarios únicos registrados.*

> - *N casos clínicos seudonimizados aportados al repositorio común.*
> - *N consultas de vademécum farmacológico local (SMS).*
> - *Coste operativo mensual: N € (servicios IA en UE, cumplimiento RGPD).*
>
> *La herramienta opera en cumplimiento del EU AI Act 2024/1689, con datos seudonimizados y región `europe-west1`. Está registrada en Propiedad Intelectual (00765-03096622).*
>
> *Solicito reunión de 30 min para valorar:*
>
> *1. Integración oficial con la intranet del SMS.*
> *2. Posibilidad de sesiones formativas reconocidas por la Comisión de Docencia.*
> *3. Ampliación a otras áreas (Murcia, Cartagena III, Lorca) si se considera útil.*
>
> *Quedo a su disposición.*
>
> ***Dr. Carlos Galera Román***
> *MFyC · H.G.U. Santa Lucía · Área II*

9. Recordatorios finales

No menciones marcas farmacéuticas en ninguna sesión (CLAUDE.md §5).
No menciones partners externos (UMU, AstraZeneca, etc. sin aprobación explícita).
Todo el contenido clínico con disclaimer formativo visible: "Plataforma formativa. No diagnóstica. No sustituye juicio clínico."
Si alguien pregunta por datos: "Seudonimizados, en UE, App Check enforcado, sin DNI ni NHC."